Master PDF Editor - Demo Version

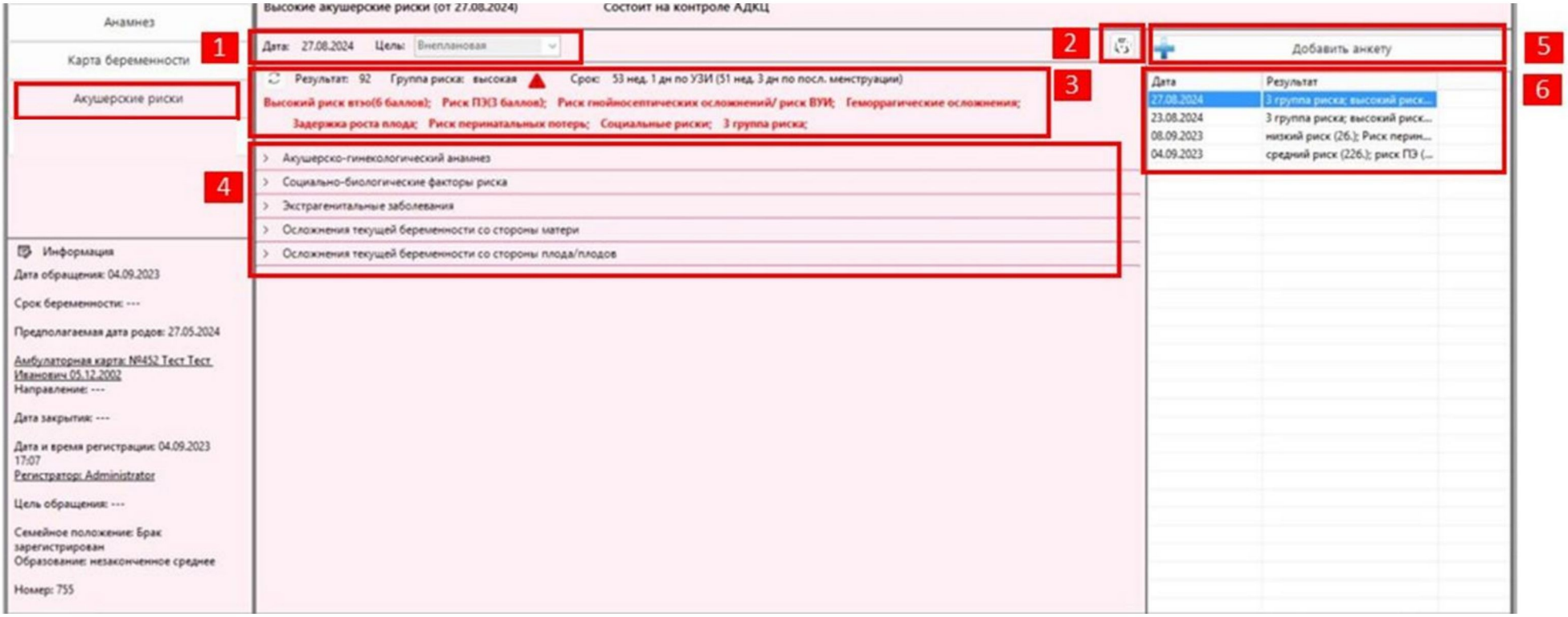
Оценка индивидуальных акушерских рисков

Оценка индивидуальных акушерских рисков осуществляется на регламентированных сроках беременности и внепланово, согласно приказу МЗ РФ 1130н.

Форма оценки и архив оценки акушерских рисков доступны во вкладке «Акушерские риски» формы «Карта беременности».

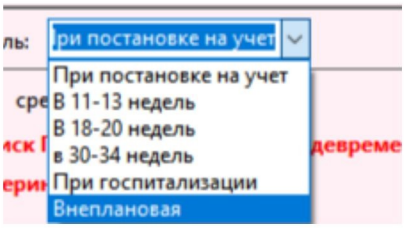
Описание вкладки «Акушерские риски»

Вкладка содержит 6 элементов.



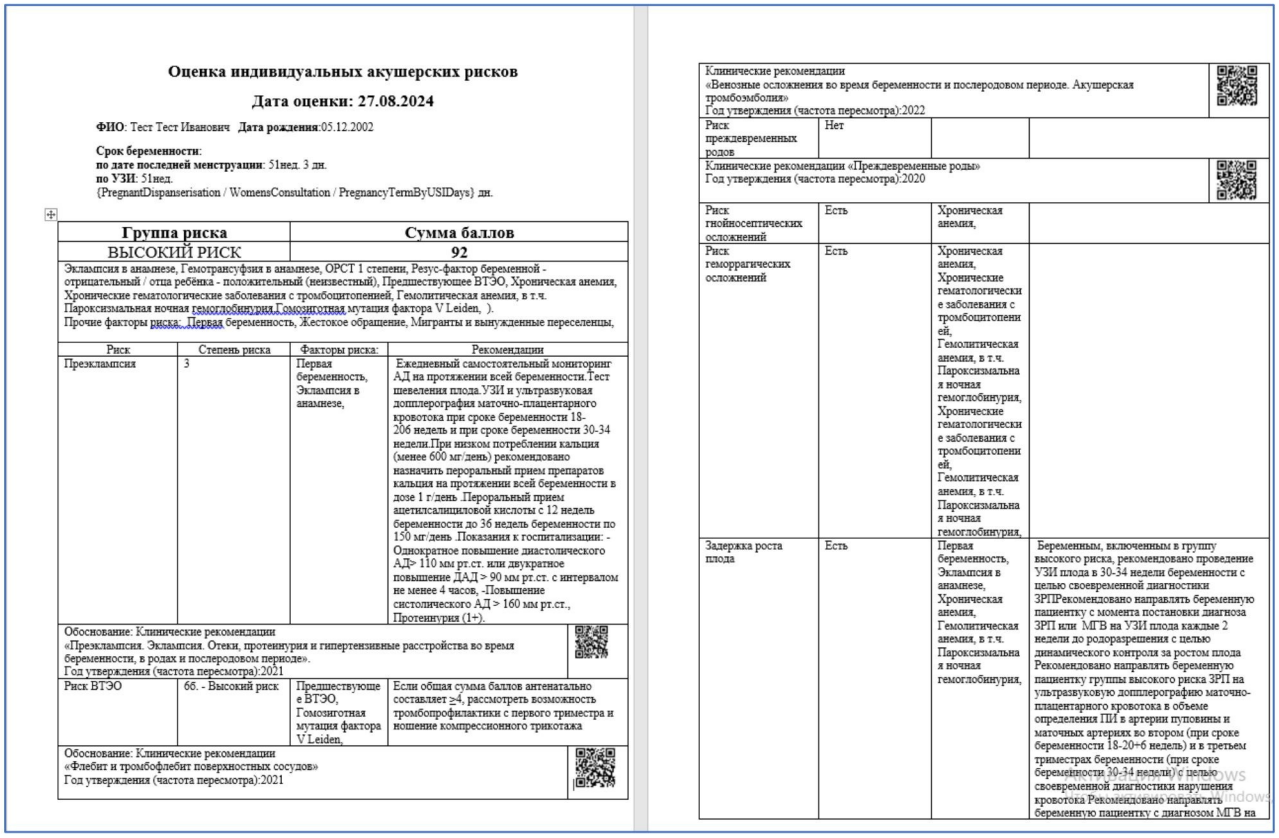
Master PDF Editor - Demo Version

Элемент 1 **Дата и цель оценки индивидуальных акушерских рисков.** Информация заполняется автоматически, дата – дата оценки риска (изменить нельзя), цель проставляется при госпитализации (можно редактировать):



Элемент 2 **Кнопка распечатки формы оценки индивидуальных акушерских рисков.** Форма для распечатки добавляется службой технической поддержки региона и может учитывать региональные особенности.

Фрагмент формы для распечатки.



Оценка индивидуальных акушерских рисков

Дата оценки: 27.08.2024

ФИО: Тест Тест Иванович **Дата рождения**:05.12.2002

Срок беременности:
по дате последней менструации: 51нед. 3 дн.
по УЗИ: 51нед.
{PregnantDispanserisation / WomensConsultation / PregnancyTermByUSIDays} дн.

Группа риска	Сумма баллов
ВЫСОКИЙ РИСК	92

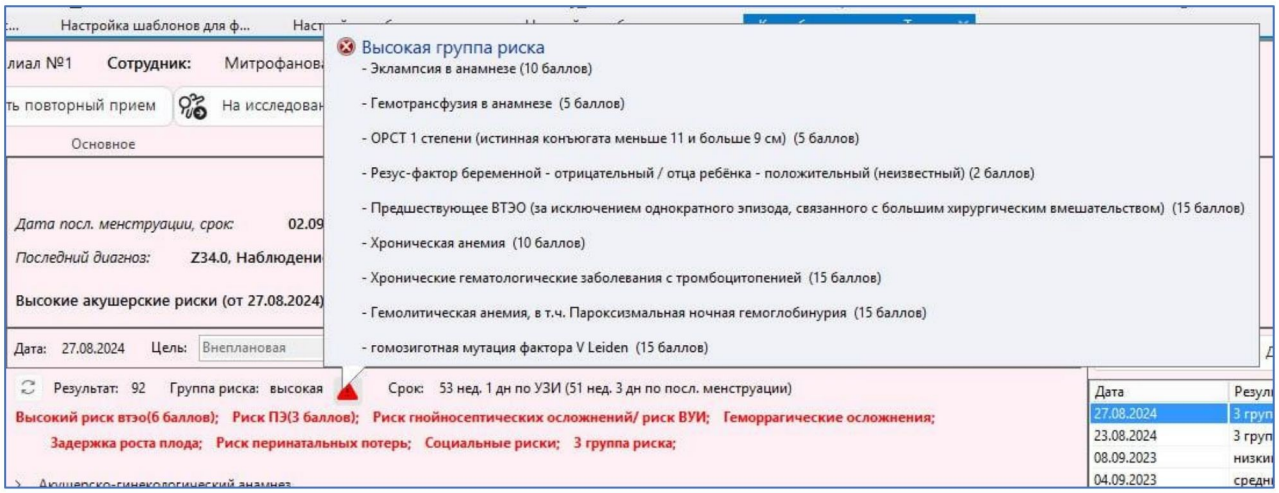
Эклампсия в анамнезе, Гемотрансуфзия в анамнезе, ОРСТ 1 степени, Резус-фактор беременной - отрицательный / отца ребёнка - положительный (неизвестный), Предшествующее ВТЭО, Хроническая анемия, Хронические гематологические заболевания с тромбоцитопенией, Гемолитическая анемия, в т.ч. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия,Гомозиготная мутация фактора V Leiden,).
Прочие факторы риска: Первая беременность, Жестокое обращение, Мигранты и вынужденные переселенцы,

Риск	Степень риска	Факторы риска:	Рекомендации
Преэклампсия	3	Первая беременность, Эклампсия в анамнезе,	Ежедневный самостоятельный мониторинг АД на протяжении всей беременности.Тест шевеления плода.УЗИ и ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при сроке беременности 18-206 недель и при сроке беременности 30-34 недели.При низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) рекомендовано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 г/день .Пероральный прием ацетилсалициловой кислоты с 12 недель беременности до 36 недель беременности по 150 мг/день .Показания к госпитализации: - Однократное повышение диастолического АД> 110 мм рт.ст. или двукратное повышение ДАД > 90 мм рт.ст. с интервалом не менее 4 часов, -Повышение систолического АД > 160 мм рт.ст., Протеинурия (1+).
Обоснование: Клинические рекомендации «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде». Год утверждения (частота пересмотра):2021			
Риск ВТЭО	6б. - Высокий риск	Предшествующее ВТЭО, Гомозиготная мутация фактора V Leiden,	Если общая сумма баллов антенатально составляет ≥4, рассмотреть возможность тромбопрофилактики с первого триместра и ношение компрессионного трикотажа
Обоснование: Клинические рекомендации «Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов» Год утверждения (частота пересмотра):2021			

Клинические рекомендации «Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия» Год утверждения (частота пересмотра):2022			
Риск преждевременных родов	Нет		
Клинические рекомендации «Преждевременные роды» Год утверждения (частота пересмотра):2020			
Риск гнойносептических осложнений	Есть	Хроническая анемия,	
Риск геморрагических осложнений	Есть	Хроническая анемия, Хронические гематологические заболевания с тромбоцитопенией, Гемолитическая анемия, в т.ч. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, Хронические гематологические заболевания с тромбоцитопенией, Гемолитическая анемия, в т.ч. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия,	
Задержка роста плода	Есть	Первая беременность, Эклампсия в анамнезе, Хроническая анемия, Гемолитическая анемия, в т.ч. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия,	Беременным, включенным в группу высокого риска, рекомендовано проведение УЗИ плода в 30-34 недели беременности с целью своевременной диагностики ЗРПРекомендовано направлять беременную пациентку с момента постановки диагноза ЗРП или МГВ на УЗИ плода каждые 2 недели до родоразрешения с целью динамического контроля за ростом плода Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска ЗРП на ультразвуковую допплерографию маточно-плацентарного кровотока в объеме определения ПИ в артерии пуповины и маточных артериях во втором (при сроке беременности 18-20+6 недель) и в третьем триместрах беременности (при сроке беременности 30-34 недели) с целью своевременной диагностики нарушения кровотока Рекомендовано направлять беременную пациентку с диагнозом МГВ на

Элемент 3 **Информация с результатом оценки рисков.** Содержит общий риск и детализацию по глобальным рискам. При наведении курсора на индикатор «Восклицательный знак в треугольнике» или на глобальный риск *(Преэклампсия, Риск ВТЭО, Риск преждевременных родов, Риск гнойносептических осложнений, Риск геморрагических осложнений, Задержка роста плода, Риск перинатальных потерь, Социальные риски)* всплывает окно с информацией за счет каких факторов рассчитался риск

Master PDF Editor - Demo Version



Элемент 4 **Блок с вкладками по факторам риска.** Содержит чек-листы оценки индивидуальных акушерских рисков.

Элемент 5 **Кнопка «Добавить анкету».** Для проведения оценки индивидуальных акушерских рисков, создает новую анкету рисков.

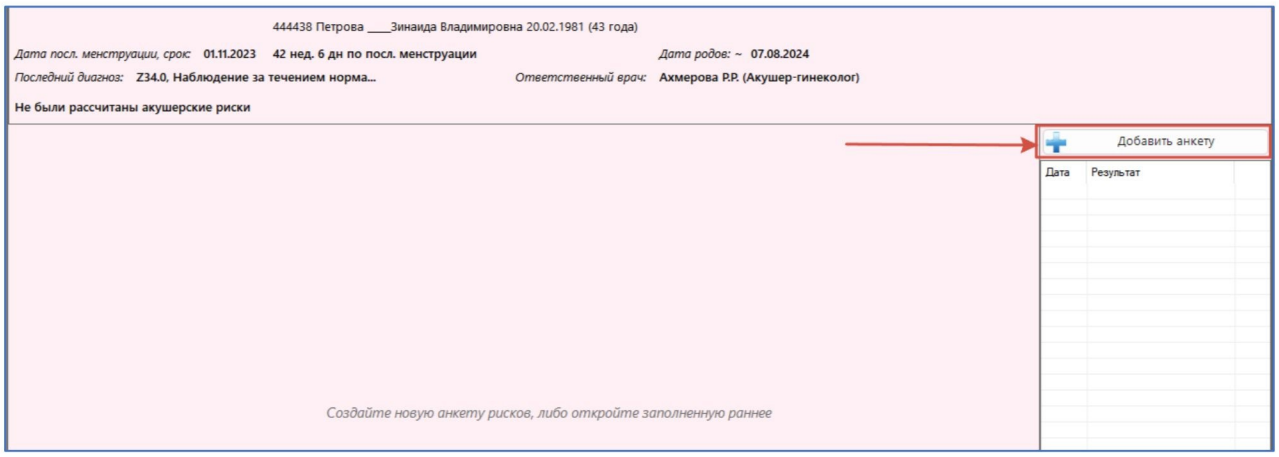
Элемент 6 **Архив оценки рисков.** Содержит информацию о ранее проведенных оценках индивидуальных акушерских рисков, с возможностью их просмотра.

Алгоритм оценки индивидуальных акушерских рисков

Внимание!
Будьте внимательны, по данным оценки индивидуальных акушерских рисков, при наличии результата 25 баллов и более (высокий акушерский риск), критериев, требующих родоразрешения в организациях третьего уровня (3 группа), социальных рисков, беременная будет автоматически добавлена на мониторинг АДКЦ.

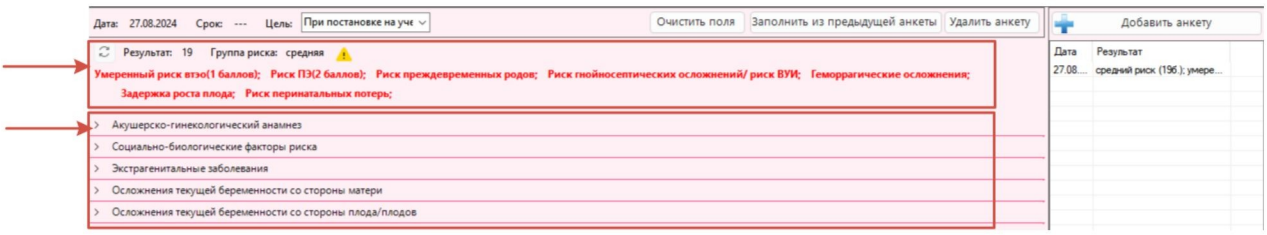
1. Выберите вкладку «Акушерские риски» на форме «Карта беременности»

2. Нажмите кнопку «Добавить анкету»

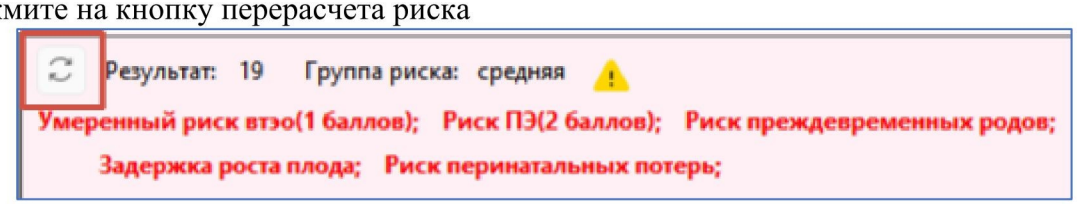


3. По данным, внесенным в карту беременности формируется предварительный риск, который необходимо уточнить, заполнив чек-листы в блоке с вкладками по факторам риска.

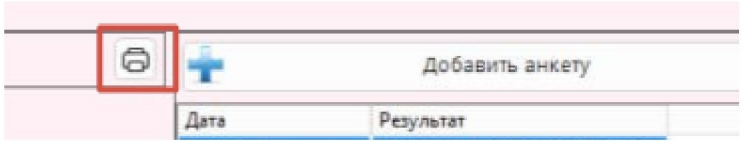
Master PDF Editor - Demo Version



4. Нажмите на кнопку перерасчета риска

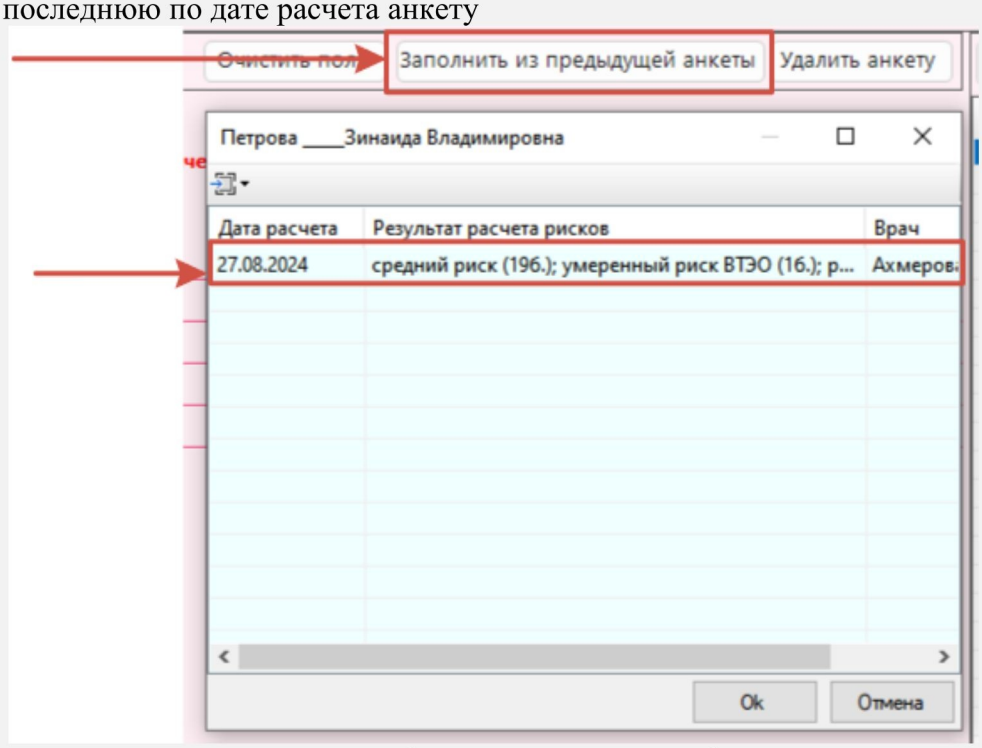


5. Нажмите на кнопку «Сохранить»
6. Распечатайте форму с оценкой риска, нажав на кнопку распечатки формы оценки индивидуальных акушерских рисков.



7. Нажмите на кнопку «Ок» для закрытия формы.

Внимание!
При оценках индивидуальных акушерских рисков, рекомендуем воспользоваться функцией «Заполнить из предыдущей анкеты»:
1. Нажмите кнопку «Заполнить из предыдущей анкеты»
2. Выберите последнюю по дате расчета анкету



3. Уточните риски, заполнив чек-листы в блоке с вкладками по факторам риска.
4. Нажмите на кнопку перерасчета риска.